

LINHA DE CUIDADO DE SAÚDE BUCAL

Versão 2.0 – 2026



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE



MISSÃO

"Promover saúde e bem-estar para as pessoas."



VISÃO

"Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil."

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PREFEITA

Rejane Gambin

SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE GESTÃO JURÍDICA E ORGANIZACIONAL

Marcianita Lopata de Lima

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE

Sheila Batista de Araújo

DIRETORIA DE VIGILÂNCIAS

Maria Cristina Antunes Willemann

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Leste

Grasiela Florencio Medeiros – Distrito Norte

Gislaine Batista de Souza – Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DA UNIDADE TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Anderson da Silva

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Allisson Domingos

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - NAT JUS

Ana Paula Barauna



GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gabriela Neves Buch

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL

Priscila Tocachelis Battistella

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ARTICULAÇÃO HOSPITALAR

Nádia Cristina Brach

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski Borges

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Gabriel Luckmann

Michelli Aparecida Rosin

Nicole Schulka

Rayane Alexandra Prochnow

Vivianne Samara Conzatti

REVISÃO/FORMATAÇÃO

Cibely Schipitoski Borges

Gislaine Batista de Souza

Juliana Antunes Safanelli

Maristela Mello de Aguiar

Roberta de Figueredo

Thais Camile Bauer de Oliveira

Thaynara Heloiza Balloni



ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO (VERSÃO 2021 PARA 2026)

Quadro 01. Alterações das versões do documento 0011088468 de 2021 para 2026

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2021	VERSÃO 2026
Referencial epidemiológico	Baseava-se nos dados do levantamento nacional de Saúde Bucal Brasil 2010.	Utiliza dados atualizados da pesquisa de Saúde Bucal Brasil 2023 e indicadores nacionais de 2025.
Estrutura normativa	Focada nas diretrizes do Programa Brasil Sorridente de 2004 e portarias vigentes até 2021.	Incorpora um arcabouço jurídico mais robusto, incluindo as Leis Orgânicas da Saúde (8.080/90 e 8.142/90) e demais legislações.
Especialidades no CEO	Listava especialidades básicas: periodontia, cirurgia oral menor, endodontia, PNE, prótese, DTM e estomatologia.	Inclusão da odontopediatria como especialidade oferecida nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).
Rede hospitalar	O Hospital Infantil era referência para cirurgia bucomaxilofacial e pacientes especiais.	Inclusão do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt para cirurgia bucomaxilofacial de fissuras labiopalatais em adultos.
Manejo e atendimento	Foco na organização do acesso e fluxogramas de atendimento geral.	Introdução da matriz de manejo para condições sistêmicas.
Ciclos de vida	Abordagem geral por faixas etárias baseada em prioridades de agendamento.	Instituição de uma matriz de cuidados odontológicos por ciclo de vida, estabelecendo metas assistenciais específicas desde bebês até idosos.
Formação e ensino	Citava a intersetorialidade e instituições de ensino de forma geral.	Consolidação da integração Ensino-Serviço através do Centro de Educação e Inovação (CEIS) e as instituições de ensino.

Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos (NGQ), 2026.



LISTA DE QUADROS

Quadro 01.	Alterações das versões do documento 0011088468 de 2021 para 2026.....	5
Quadro 02.	Composição da RASB - Rede de Atenção à Saúde Bucal.....	17
Quadro 03.	Estrutura e Atribuições da Equipe de Saúde Bucal (eSB).....	19
Quadro 04.	Composição das principais Atribuições da eSB.....	20
Quadro 05.	Distribuição média das vagas de primeira consulta na Atenção Primária.....	21
Quadro 06.	Classificação de Risco Individual à Cárie (Levantamento de Joinville).....	24
Quadro 07.	Pontos da RASB e Especialidades Odontológicas.....	28
Quadro 08.	Matriz de Cuidados Odontológicos por Ciclo de Vida.....	29
Quadro 09.	Matriz de Manejo para Condições Sistêmicas.....	30
Quadro 10.	Unidades de Referência Especializada em Joinville.....	32
Quadro 11.	Principais modalidades odontológicas a distância.....	34
Quadro 12.	Fluxo por Faixa Etária e critérios da Unidade de Referência.....	36
Quadro 13.	Matriz de Indicações Radiográficas.....	50
Quadro 14.	Matriz de Exames Laboratoriais na Odontologia.....	50
Quadro 15.	Matriz de Indicadores e Instrumentos de Gestão.....	52
Quadro 16.	Responsabilidades na Integração Ensino-Serviço.....	54



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AEA: Atenção Especializada Ambulatorial.
AEH: Atenção Hospitalar.
AINEs: Anti-inflamatórios Não Esteroidais.
APS: Atenção Primária à Saúde.
ART: Tratamento Restaurador Atraumático.
ASB: Auxiliar de Saúde Bucal.
ATF: Aplicação Tópica de Flúor.
BPA-I: Boletim de Produção Ambulatorial – Dados Individualizados
CD: Cirurgião-Dentista.
CEO: Centros de Especialidades Odontológicas.
CEO-D: Cariado, Extraído e Obturado em Dentes Decíduos.
CEIS: Centro de Educação e Inovação em Saúde.
CFO: Conselho Federal de Odontologia.
CIDs: Classificação Internacional de Doenças.
CIAPs: Classificação Internacional de Atenção Primária.
CNS: Cartão Nacional de Saúde.
CPF: Cadastro de Pessoa Física.
COAPES: Contratos Organizativos de Ação Pública de Ensino-Saúde.
CTBMF: Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.
DEFs: Dispositivos Eletrônicos para Fumar.
DM: Diabetes Mellitus.
DTM: Disfunção Temporomandibular.
EDS: Escovação Dental Supervisionada.
eSB: Equipe de Saúde Bucal.
ESF: Estratégia Saúde da Família.
HAS: Hipertensão Arterial.
HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana.
HMSJ: Hospital Municipal São José.
ILP: Institutos de Longa Permanência.
LRPD: Laboratório Regional de Prótese Dentária.
NAIPE DI/TEA: Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo.
NGQ: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos.
PA: Pressão Arterial.
PNAISP: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.
PcD: Pessoas com Deficiência.
PNAB: Política Nacional de Atenção Básica.
PNE: Pessoas com Necessidades Especiais.
PNSB: Política Nacional de Saúde Bucal.
POPs: Procedimentos Operacionais Padrão.
PSE: Programa Saúde na Escola.
RAS: Rede de Atenção à Saúde.
REMUME: Relação Municipal de Medicamentos.
RASB: Rede de Atenção à Saúde Bucal.
SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
SB Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.
SEI: Sistema Eletrônico de Informação.



SIG-SaudeTech: Sistema Integrado de Gestão.
SISREG: Sistema Nacional de Regulação.
SUS: Sistema Único de Saúde.
STT/SC: Sistema Integrado de Telemedicina e Telessaúde de Santa Catarina.
TAP: Tempo de Atividade da Protrombina.
TTPA: Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada.
TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
TFD: Tratamento Fora de Domicílio.
TSB: Técnico em Saúde Bucal.
UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família.
UNACON: Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.
UPA: Unidade de Pronto Atendimento.
VHS: Velocidade de Hemossedimentação.
VIGIAGUA: Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano.



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	12
INTRODUÇÃO.....	13
1. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO.....	15
2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.....	16
2.1 MARCO REGULATÓRIO E ABRANGÊNCIA DA ATENÇÃO.....	16
2.2 A ORGANIZAÇÃO DA REDE E OS PONTOS DE ATENÇÃO.....	17
2.2.1 Atenção Primária à Saúde (APS).....	18
2.2.2 Equipe de saúde bucal na APS.....	18
2.2.3 Atribuições e responsabilidades da eSB na unidade.....	20
2.2.4 Primeira consulta odontológica na APS.....	21
2.2.4.1 Distribuição e priorização de vagas.....	21
2.2.4.2 Consultas de retorno.....	22
2.2.5 Ações coletivas e promoção da saúde.....	22
2.2.5.1 Aplicação tópica de flúor (ATF) Coletiva.....	23
2.2.5.2 Escovação Dental Supervisionada (EDS).....	23
2.2.5.3 Exame bucal com finalidade epidemiológica.....	23
2.2.6 Educação em saúde e fortalecimento da autonomia.....	24
2.2.6.1 Programa municipal de controle do tabagismo.....	24
2.2.6.2 Campanha de prevenção e diagnóstico do câncer bucal.....	25
2.2.6.3 Programa Saúde na Escola (PSE).....	25
2.2.6.4 Visitas e atendimentos domiciliares.....	26
2.2.7 Grupos de atenção à saúde bucal.....	26
2.2.8 Atendimento às urgências odontológicas na APS.....	27
2.2.8.1 Fluxo e organização da agenda para urgências na APS.....	27
2.2.8.2 Natureza das urgências.....	27
2.2.9 Continuidade do cuidado: encaminhamentos e referência.....	28
2.2.9.1 Controle de contra referências e continuidade do cuidado.....	29
2.2.10 Atenção por ciclo de vida.....	29
2.2.11 Condições de saúde específicas.....	30
2.3 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E SERVIÇOS ESPECIAIS.....	31
2.3.1 Pontos de atenção e especialidades.....	32
2.3.2 Fluxo assistencial e regulação.....	32
2.3.3 A contrarreferência e a continuidade do cuidado.....	33
2.4 TELEODONTOLOGIA (RESOLUÇÃO CFO-SEC-278/2025).....	33
2.5 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR.....	35
2.5.1 Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA/PA).....	35
2.6 ATENÇÃO HOSPITALAR.....	35
2.6.1 Fluxo por faixa etária (Deliberação 181/CIB/2017).....	35
2.6.2 Competências da atenção hospitalar.....	36
2.6.3 Perfil das unidades de referência.....	36
2.7 ACESSO A SERVIÇOS SECUNDÁRIOS, TERCIÁRIOS E AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS.....	37



2.7.1 Cirurgia e trauma bucomaxilofacial.....	37
2.7.1.1 Critérios de inclusão.....	37
2.7.1.2 Critérios de exclusão.....	38
2.7.2 Estomatologia.....	38
2.7.2.1 Critérios de inclusão.....	38
2.7.2.2 Critérios de exclusão.....	39
2.7.3 Cirurgia oral menor.....	39
2.7.3.1 Critérios de inclusão.....	39
2.7.3.2 Critérios de exclusão.....	40
2.7.4 Endodontia.....	41
2.7.4.1 Critérios de inclusão.....	41
2.7.4.2 Critérios de exclusão.....	41
2.7.4.3 Acompanhamento especializado após endodontia.....	42
2.7.5 Odontopediatria.....	42
2.7.5.1 Critérios de inclusão.....	42
2.7.5.2 Critérios de exclusão.....	42
2.7.6 Disfunção temporomandibular e dor orofacial.....	42
2.7.6.1 Critérios de inclusão.....	43
2.7.6.2 Critérios de exclusão.....	43
2.7.7 Periodontia.....	44
2.7.7.1 Critérios de inclusão.....	44
2.7.7.2 Critérios de exclusão.....	44
2.7.8 Prótese total.....	45
2.7.8.2 Critérios de exclusão.....	45
2.7.9 Pacientes com Necessidades Especiais (PNE).....	46
2.7.9.1 Critérios de inclusão.....	46
2.7.9.2 Critérios de exclusão.....	46
2.8 SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO.....	47
2.8.1 Assistência farmacêutica.....	47
2.8.2 Radiologia odontológica.....	47
2.8.2.1 Radiografias intrabucais.....	47
2.8.2.2 Radiografias extrabucais.....	48
2.8.2.3 Demais radiografias extrabucais.....	49
2.8.3 Exames laboratoriais (Análises clínicas).....	50
2.9 SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS OU LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD).....	51
3. INDICADORES, MONITORAMENTO E CONTROLE.....	51
3.1 NÍVEIS DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO.....	52
3.2 O PAPEL DO REGISTRO.....	52
4. INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO (PARCERIAS).....	53
4.1 O CONTRATO ORGANIZATIVO (COAPES).....	53
4.2 FLUXO DE ESTÁGIOS EM JOINVILLE.....	53
4.3 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE RECEPTORA.....	54
5. PROPÓSITO E DIRETRIZES DA REDE DE CUIDADO.....	54



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	55
ANEXOS.....	57
ANEXO A. Fluxogramas de acesso à RASB - APS.....	57



APRESENTAÇÃO

Este documento constitui a versão revisada da Linha de Cuidado da Saúde Bucal no município. A atualização foi realizada por um grupo de trabalho composto por representantes da Atenção Primária à Saúde (APS), Serviços Especializados, Vigilância em Saúde, Planejamento Estratégico e outras áreas correlatas.

A revisão desta Linha de Cuidado foi pautada nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) em 2004, identificada pelo programa “Brasil Sorridente” e consolidada em 2023 pela Lei nº 14.572 como uma política de estado permanente, marcou a reorganização do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo a saúde bucal como um componente essencial da atenção integral.

Desta forma, esta linha de cuidado constitui-se como o instrumento norteador para a organização e a qualificação da assistência odontológica.

O fluxo assistencial e as responsabilidades dos diferentes pontos de atenção, objetivam assegurar à população o acesso oportuno e a longitudinalidade do cuidado, fundamentando-se nas diretrizes do SUS e nas melhores práticas clínicas, otimizando a utilização dos recursos e fortalecendo a articulação entre os diversos níveis de atenção, garantindo a promoção, a prevenção e a reabilitação necessária para responder às demandas de saúde bucal e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos joinvilenses.



INTRODUÇÃO

As legislações que regem o atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde (SUS) formam uma estrutura interdependente onde a Constituição Federal de 1988 estabelece o alicerce fundamental, garantindo a saúde como um direito universal e definindo os princípios doutrinários e organizativos que norteiam o sistema; as leis orgânicas da saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90) operacionalizam esse arcabouço ao definir as competências de cada esfera governamental, as fontes de financiamento e a participação ativa da comunidade na gestão do sistema.

A implantação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) em 2004, identificada pelo programa “Brasil Sorridente” e consolidada em 2023 pela Lei nº 14.572 como uma política de estado permanente, marcou a reorganização do cuidado no SUS, estabelecendo a saúde bucal como um componente essencial da atenção integral. Sob as diretrizes e atributos da Atenção Primária à Saúde (APS), os atendimentos passaram a ser orientados pelo conhecimento da realidade socioeconômica e cultural da população, utilizando indicadores de morbimortalidade como ferramentas fundamentais para o planejamento e monitoramento das ações.

A estruturação dessa atenção no SUS é regida por um arcabouço normativo que inclui portarias, resoluções e notas técnicas do Ministério da Saúde. Entre os pilares dessa organização, destacam-se:

- Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente): que estabelece as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento da atenção odontológica no país;
- Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB): que organiza os serviços em níveis de complexidade, da Atenção Primária à hospitalar, definindo fluxos assistenciais e sistemas de referência.

Somam-se a essas diretrizes os preceitos do código de ética odontológica e as resoluções do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Tais normas são de observância obrigatória para todos os cirurgiões-dentistas e profissionais técnicos e auxiliares que atuam no SUS, garantindo que a prática profissional seja pautada pela qualidade técnica e pela integridade ética. É a partir dessa base normativa e estrutural que se organiza o processo de trabalho das equipes de Saúde Bucal (eSB).

O processo de trabalho dessas equipes fundamenta-se nos princípios da universalidade e equidade, buscando evitar encaminhamentos desnecessários ao fortalecer a APS como a principal porta de entrada e ordenadora da RASB. Assim, a



PNSB articula a atenção básica à Atenção Especializada Ambulatorial (AEA), através de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios de Prótese Dentária (LRPD), e à Atenção Hospitalar (AEH).

A saúde bucal é um componente indissociável da saúde geral e da qualidade de vida, estando intrinsecamente ligada aos determinantes socioeconômicos e ao acesso aos serviços de saúde. No Brasil, apesar dos avanços consolidados, as doenças bucais permanecem como desafios relevantes de saúde pública, com uma distribuição desigual entre regiões e grupos populacionais. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil, 2023) revelam que a cárie dentária ainda apresenta elevada prevalência, tanto na dentição decídua quanto na permanente.

Desta forma, esta linha de cuidado constitui-se como o instrumento norteador para a organização e a qualificação da assistência odontológica em Joinville. Seu objetivo é delinear o fluxo assistencial e as responsabilidades dos diferentes pontos de atenção, assegurando à população o acesso oportuno e a longitudinalidade do cuidado. Ao fundamentar-se nas diretrizes do SUS e nas melhores práticas clínicas, este documento busca otimizar a utilização dos recursos e fortalecer a articulação entre os diversos níveis de atenção, garantindo a promoção, a prevenção e a reabilitação necessárias para responder às demandas de saúde bucal e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos joinvilenses.

1. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO

No que tange aos indicadores epidemiológicos, o cenário nacional (Brasil, 2025) aponta um índice médio de dentes decíduos cariados, extraídos e obturados (ceo-d) de 2,14 em crianças, sendo que 53,17% delas estão livres de cárie. Contudo, aproximadamente 40% das crianças e adolescentes ainda apresentam cárie não tratada, condição que se agrava com a idade, atingindo mais da metade dos adultos e cerca de um terço dos idosos brasileiros.

Em uma análise regional, a região sul apresenta indicadores mais favoráveis, fruto da expansão histórica da Estratégia Saúde da Família (ESF) e das eSB. Santa Catarina destaca-se positivamente com um dos menores índices ceo-d do país na dentição decídua (1,43) e a maior proporção de dentes restaurados (41,31%), o que sugere uma capacidade resolutiva superior.

No entanto, o SB Brasil 2023 alerta para a persistência de desigualdades e para o impacto de condições como doenças periodontais e perdas dentárias, que demandam uma rede focada na integralidade do cuidado.

A rede de saúde bucal do município atua em consonância com o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), realizando o monitoramento sistemático e a vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público. Esta medida, reconhecida como uma das principais estratégias de saúde pública para a prevenção da cárie dentária, é acompanhada através de análises periódicas de teores de flúor, garantindo que os níveis permaneçam dentro dos parâmetros ideais de proteção e segurança biológica.



2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

2.1 MARCO REGULATÓRIO E ABRANGÊNCIA DA ATENÇÃO

A organização da assistência odontológica no município é regida pela Portaria GM/MS Nº 6.213, de 19 de dezembro de 2024, que institui a Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB). Este dispositivo legal consolida o cuidado odontológico como um direito fundamental, estabelecendo a integração e a articulação obrigatória entre os diferentes níveis de atenção: primária, especializada ambulatorial (CEO/LRPD), hospitalar, urgência/emergência e os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. O objetivo central é assegurar ao cidadão um acesso amplo, equitativo e, sobretudo, resolutivo em todas as etapas de sua necessidade de saúde.

Nesse cenário, a atenção em saúde bucal transcende o ato clínico isolado, ela compreende um conjunto de ações transversais que envolvem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, a recuperação e a reabilitação. Mais do que o tratamento de doenças, a RASB em Joinville busca o acompanhamento longitudinal do usuário, garantindo que o cuidado seja contínuo e que os fluxos de referência entre a unidade básica e o serviço especializado funcionem de maneira ágil e segura.

Adicionalmente, a rede de saúde bucal assegura o cuidado integral à população em situação de rua, em consonância com a política nacional para a população em situação de rua (Decreto nº 7.053/2009) e as diretrizes das equipes de consultório na rua. O atendimento odontológico para este público deve ser pautado pela redução de danos, pela flexibilização do acesso, garantindo o atendimento mesmo na ausência de documentação ou comprovante de residência, e pela busca ativa em territórios de vulnerabilidade. Da mesma forma, a linha de cuidado estende-se às populações nômades, ciganas e de matrizes tradicionais, respeitando suas especificidades culturais e garantindo que a barreira geográfica ou a transitoriedade não impeçam o acesso às ações de promoção e recuperação da saúde bucal. O foco reside na equidade, assegurando que o suporte clínico e preventivo alcance os indivíduos onde eles estiverem, fortalecendo a rede de proteção social e o direito universal à saúde.

No que tange aos imigrantes, refugiados e apátridas, a RASB de Joinville assegura o atendimento integral em conformidade com a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) e os princípios de universalidade do SUS. O acesso às ações de saúde bucal na APS deve ser garantido independentemente da situação migratória ou documental, não sendo a ausência de Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão SUS ou



comprovante de residência um impeditivo para o acolhimento e tratamento.

A atuação das equipes deve ser pautada pela sensibilidade cultural e pelo esforço na superação de barreiras linguísticas, reconhecendo a saúde como um direito humano fundamental e promovendo a inclusão desses cidadãos na rede de cuidados, visando a redução de vulnerabilidades e a garantia da dignidade humana no território municipal.

Complementarmente, o exercício da odontologia e as práticas clínicas no âmbito do SUS são rigorosamente fundamentados nas normativas éticas e legais estabelecidas pelo CFO. Estas recomendações técnicas e de conduta zelam pela excelência do atendimento e pela segurança do paciente, assegurando que o serviço público seja prestado com o mais alto rigor técnico-científico e humanizado, em consonância com as diretrizes de "A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde" (Brasília, 2018).

Quadro 02. Composição da RASB - Rede de Atenção à Saúde Bucal

NÍVEL DE ATENÇÃO	PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
Atenção Primária à Saúde	Unidades Básicas de Saúde
Atenção Especializada Ambulatorial	Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)
Atenção Especializada Hospitalar e de Urgência e Emergência	Suporte Hospitalar e Unidades de Urgência e Emergência
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	Serviços de suporte: laboratórios de análises clínicas, imaginologia (radiografias, tomografias), próteses, entre outros

Fonte: Portaria GM/MS Nº 6.213, de 19 de Dezembro de 2024.

Desta forma, a consolidação da RASB no município pressupõe que as ações em Saúde Bucal devem abarcar o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno dos usuários, interrompendo o processo de adoecimento desde o seu primeiro contato com o sistema. Esse acesso deve iniciar na APS, podendo permear, conforme a necessidade clínica e a complexidade do caso, os serviços da atenção especializada, ambulatorial e hospitalar.

2.2 A ORGANIZAÇÃO DA REDE E OS PONTOS DE ATENÇÃO

Para que o sistema opere com eficiência, a rede organiza-se de maneira

hierarquizada, onde cada ponto de atenção possui competências clínicas e administrativas bem definidas, mas que se mantêm em constante comunicação. Este capítulo detalha o funcionamento operacional dos serviços, estabelecendo as diretrizes que norteiam desde o acolhimento na unidade básica até o suporte especializado, garantindo que o percurso do usuário pelo sistema seja pautado pela continuidade da assistência e pela otimização dos recursos municipais.

2.2.1 Atenção Primária à Saúde (APS)

As Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) constituem a principal porta de entrada do SUS, atuando como o centro coordenador do cuidado e o principal ponto de vínculo com a comunidade. Fundamentada na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria nº 2.436/2017, a APS prioriza a promoção da saúde e a prevenção de agravos, garantindo que o usuário receba atendimento odontológico integral na unidade de referência correspondente à sua área de abrangência residencial.

A UBSF detém a responsabilidade técnica e ética pelo cadastramento e acompanhamento longitudinal da população em seu território de atuação. É a unidade de referência para a vasta maioria das demandas clínicas, excetuando-se apenas situações que configurem risco iminente de morte ou urgências agudas que exijam suporte 24 horas. Nestes casos específicos, o fluxo assistencial deve ser direcionado às Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), hospitais gerais ou serviços habilitados em média e alta complexidade.

Complementarmente, a RASB do município estende sua atuação à população carcerária, em estrita observância à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), conforme a Portaria nº 482/2014. A assistência odontológica no contexto das unidades de saúde prisional compartilha as mesmas diretrizes da APS, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, mas com foco acentuado na redução de iniquidades e no enfrentamento das vulnerabilidades psicossociais e epidemiológicas específicas deste grupo, assegurando-lhes o direito constitucional à saúde.

2.2.2 Equipe de saúde bucal na APS

A eSB em Joinville atua de forma integrada e complementar à ESF, sendo um pilar essencial para a resolutividade da Atenção Primária. A composição da equipe, Cirurgião-Dentista (CD), Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) e/ou Técnico em Saúde Bucal

(TSB), visa garantir a abrangência do cuidado por meio de competências interdependentes, conforme as prerrogativas da Lei nº 11.889/2008 e Nota Técnica nº 34/2026 - CGSB/DESF/SAPS/MS.

Quadro 03. Estrutura e atribuições da Equipe de Saúde Bucal (eSB)

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÍVEL DE ATUAÇÃO	ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS	GESTÃO E EDUCAÇÃO
Cirurgião-Dentista (CD)	Superior	Realização de consultas clínicas, exames bucais, procedimentos preventivos, curativos e pequenas cirurgias ambulatoriais.	Atua na coordenação da eSB, na educação em saúde voltada à comunidade e na articulação com a equipe multiprofissional da UBSF para ações de promoção à saúde.
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)	Auxiliar	Suporte operacional e na organização e manutenção do consultório, instrumentação durante os procedimentos, manipulação de materiais odontológicos, processamento de artigos (esterilização), atividades educativas e coletivas, incluindo Ação coletiva de aplicação de flúor (seja com supervisão direta e/ou indireta) e controle de biossegurança. (Nota Técnica nº 34/2026)	Atua na recepção do usuário, agendamento de consultas e organização dos prontuários e registros epidemiológicos. Auxilia na instrumentação do CD e do TSB durante os procedimentos clínicos, a manipulação de materiais odontológicos, o controle de infecção e a biossegurança.
Técnico em Saúde Bucal (TSB)	Técnico	Além das tarefas de suporte do ASB, o TSB realiza a aplicação de medidas preventivas (selantes e fluoterapia), radiografias intraorais, remoção de biofilme e tártaro sempre seguindo as diretrizes e protocolos estabelecidos. (Lei nº 11.889/2008).	Profissional de nível técnico que atua sob a supervisão do Cirurgião-Dentista, possui um escopo de atuação clínica preventiva expandido. Além de colaborar no treinamento de auxiliares e na coleta de dados para levantamentos epidemiológicos.

Elaborado: NGQ, 2026.



Nota Operacional (Ausência do CD):

Na ausência temporária do cirurgião-dentista, o TSB ou ASB deve priorizar o acolhimento e a orientação dos usuários, especialmente em casos de urgência. Cabe à equipe realizar o remanejamento de consultas, a organização do consultório sob normas de biossegurança, a digitação de atividades coletivas e o suporte administrativo ou assistencial (dentro de suas atribuições) às demais equipes da unidade ou supervisores de estágio. Na ausência do CD, o TSB e o ASB podem dar continuidade às atividades extraclínica planejadas (como as ações coletivas do PSE e visitas domiciliares de orientação) sob a modalidade de supervisão indireta. (Nota Técnica nº 34/2026-CGSB/SAPS/MS)

Nota Operacional (Ausência ASB ou TSB):

Na ausência dos profissionais auxiliares ou técnicos, o cirurgião-dentista assume a execução integral das etapas do atendimento, respeitando sua jornada de trabalho. Nestas circunstâncias, estima-se uma redução da capacidade operacional da agenda para cerca de 50%, podendo variar conforme a complexidade dos procedimentos programados e a necessidade de tempo adicional para a organização e desinfecção do ambiente entre os pacientes.

2.2.3 Atribuições e responsabilidades da eSB na unidade

A eSB na APS é corresponsável pela saúde da população de seu território, atuando de forma interdisciplinar com as ESF. O foco central é a garantia da integralidade, utilizando ferramentas de clínica ampliada e vigilância em saúde. O **Quadro 04** apresenta as principais atribuições das eSBs em Joinville.

Quadro 04. Composição das principais atribuições da eSB

COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA eSB	
Assistência e Manejo Clínico	Realização de atendimentos clínicos odontológicos programados e acolhimento da demanda espontânea. Inclui a identificação, o diagnóstico e o tratamento imediato de urgências odontológicas no âmbito da APS.
Gestão do Cuidado e Fluxo em Rede	Coordenação do cuidado do usuário, realizando o encaminhamento (referência) para a atenção especializada (CEO) e serviços de apoio quando a complexidade clínica exigir.
Ações de Promoção e Prevenção	Planejamento e execução de atividades de educação em saúde, orientação de higiene bucal, escovação supervisionada e aplicação de métodos preventivos coletivos e individuais.



Visitas Domiciliares	Visitas domiciliares, para usuários acamados ou mobilidade reduzida.
Atendimento a Grupos Prioritários	Organização de agendas e protocolos específicos para o acompanhamento de gestantes, crianças, idosos, pacientes com doenças crônicas e pessoas com deficiências, e solicitar busca ativa de faltosos em tratamentos prioritários.
Monitoramento e Registro nos Sistemas de Informação	Alimentação dos sistemas de informação em saúde (prontuário eletrônico), registro de atividades coletivas e gerenciamento de estoque e insumos odontológicos. Acompanhamento de indicadores e metas.

Elaborado: NGQ, 2026.

2.2.4 Primeira consulta odontológica na APS

A Primeira consulta odontológica representa o momento de ingresso do usuário no plano terapêutico da APS. O agendamento é realizado pela recepção da UBSF, seguindo diretrizes de planejamento local que buscam equilibrar a demanda espontânea e o atendimento a grupos estratégicos.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Antes de qualquer intervenção é obrigatória a assinatura do TCLE (Disponível no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech): Prescrições livres > Termo > TCLE). Após a assinatura, o documento deverá ser arquivado no consultório.

2.2.4.1 Distribuição e priorização de vagas

Conforme as diretrizes municipais e em observância à Lei nº 10.048/2000, o fluxo de agendamento deve priorizar grupos com maior vulnerabilidade biológica ou social. Como parâmetro norteador, estabelece-se a reserva de vagas conforme o Quadro 05, podendo esta proporção ser ajustada pelas eSBs conforme a realidade epidemiológica de cada território.

Quadro 05. Distribuição média das vagas de primeira consulta na Atenção Primária

PÚBLICO ALVO	
Usuários não prioritários – 40%	Público prioritário* – 60%

Elaborado: NGQ, 2026.

*Gestantes; Pessoas com deficiência; Idosos; Crianças entre 0 e 5 anos; Centro de educação infantil; Escolares até 9º ano; Crianças em tratamento oncológico.

Excepcionalmente para o agendamento de escolares (educação infantil e ensino fundamental), devido à pactuação do Programa Saúde na Escola (PSE), o responsável legal possui a prerrogativa de optar pelo atendimento na UBSF de abrangência da instituição de ensino ou na UBSF de referência de sua residência, facilitando o acesso e a adesão ao tratamento. Na consulta inicial, o cirurgião-dentista deve realizar anamnese completa e exame clínico minucioso, consolidando o diagnóstico e o Plano de Tratamento Individualizado.

Sempre que houver viabilidade clínica e tempo hábil, procedimentos preventivos ou curativos iniciais (como orientação, escovação supervisionada, profilaxia ou aplicação de flúor) devem ser realizados para otimizar o acesso.

2.2.4.2 Consultas de retorno

As consultas de retorno, destinadas à continuidade do plano de tratamento, são agendadas diretamente no consultório odontológico pela própria eSB. O planejamento da agenda deve prever, em média, 30 minutos de duração por consulta. Em casos que exijam maior densidade operacional, como exodontias múltiplas, restaurações complexas ou cirurgias ambulatoriais, o tempo de atendimento poderá ser estendido. Essa flexibilização deve ocorrer mediante critério clínico e ciência da coordenação da UBSF, visando a otimização do tempo e a resolutividade do procedimento.

2.2.5 Ações coletivas e promoção da saúde

Em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), a atuação das eSBs em Joinville deve equilibrar a assistência clínica individual com ações estratégicas de promoção e prevenção. O objetivo é garantir a integralidade do cuidado, não se limitando ao atendimento em consultório, mas estendendo a presença da odontologia para o território e para os espaços coletivos.

As eSB devem dedicar parte de sua carga horária ao desenvolvimento de ações de



saúde pública, planejamento territorial e educação permanente.

Para favorecer a integralidade e a redução de agravos na população adscrita, os seguintes serviços e ações coletivas são preconizados.

2.2.5.1 Aplicação tópica de flúor (ATF) Coletiva

A aplicação tópica de gel fluoretado (flúor-fosfato acidulado a 1,23%) é uma atividade estratégica de prevenção à cárie dentária, executada pelo CD, TSB ou pelo ASB sob supervisão do CD.

- Protocolo: recomenda-se o tempo de exposição mínima de um minuto, conforme evidências clínicas consolidadas;
- Público-alvo: a ação é prioritária para escolares acima de 6 anos e comunidades com alta prevalência de cárie ou barreiras de acesso a outras formas de prevenção (Guia de fluoretos no Brasil, 2026).

2.2.5.2 Escovação Dental Supervisionada (EDS)

As ações da Educação Dental Supervisionada (EDS) em Joinville são fundamentais para a educação em saúde e podem ser executadas em duas modalidades, conforme a Nota Técnica nº 23/2020-MS:

- Modalidade direta: os profissionais da eSB realizam o planejamento, a execução clínica e a avaliação direta da atividade;
- Modalidade indireta: a eSB atua no planejamento e na capacitação de multiplicadores (agentes comunitários de saúde, professores e cuidadores), que passam a executar a escovação.

2.2.5.3 Exame bucal com finalidade epidemiológica

A cada dois anos, as eSBs realizam o levantamento epidemiológico nas unidades de ensino (municipais e estaduais), abrangendo desde a educação infantil até o ensino fundamental (9º ano). O objetivo é mapear a saúde periodontal, higiene e o risco à cárie, direcionando a conduta conforme a classificação de risco, o que pode ser observado no Quadro 06.



Quadro 06. Classificação de risco individual à cárie (levantamento de Joinville)

CLASSIFICAÇÃO	QUADRO CLÍNICO	CONDUTA PRECONIZADA
Tratamento Concluído (TC)	Ausência de sinais de atividade de doença e sem histórico pregresso.	Manutenção e orientações preventivas gerais.
Risco 1 (Baixo)	Presença de biofilme, manchamentos extrínsecos ou hábitos (ex: chupeta), sem necessidade de intervenção invasiva.	Educação em saúde, orientação de escovação e Aplicação Tópica de Flúor (ATF).
Risco 2 (Médio)	Alterações leves/moderadas: manchas brancas ativas ou até duas lesões de cárie em dentes decíduos ou permanentes.	Encaminhamento do escolar e seu responsável para a UBSF de referência.
Risco 3 (Alto)	Alterações moderadas/gravas: três ou mais lesões de cárie e/ou processos infecciosos ativos.	Orientação e agendamento prioritário na UBSF de referência.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, 2025.

Normativa:

O registro obrigatório deste exame deve seguir rigorosamente o POP nº 45, Registro de Ações de Avaliação/Procedimento Coletivo do Programa Saúde na Escola (PSE) no Prontuário Eletrônico do Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech), disponível em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#).

2.2.6 Educação em saúde e fortalecimento da autonomia

As ações de educação em saúde bucal em Joinville seguem as diretrizes da PNSB, visando fortalecer a autonomia do usuário no controle do processo saúde-doença. O objetivo é transformar o cidadão em sujeito proativo, promovendo mudanças comportamentais duradouras.

- Grupos multiprofissionais: a eSB deve participar ativamente dos grupos desenvolvidos nas UBSFs, tais como: puericultura, adolescentes, gestantes, grupos de doenças crônicas, saúde mental, tabagismo, idosos e demais grupos de hábitos saudáveis de vida.

2.2.6.1 Programa municipal de controle do tabagismo

O cirurgião-dentista possui um papel estratégico na cessação do tabagismo, devido



à sua capacidade de identificar precocemente as alterações na mucosa bucal e monitorar os efeitos do hábito.

- Capacitação e atuação: profissionais capacitados em "Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS" podem coordenar grupos terapêuticos e realizar a prescrição de gomas e adesivos de nicotina fornecidos pela Secretaria de Saúde;
- Protocolo no grupo: durante as consultas do programa, devem ser realizadas orientações, palestras e exames clínicos minuciosos para detecção de lesões bucais em todos os participantes ativos;
- Registro e normativas: a produção dos grupos de tabagismo deve ser registrada obrigatoriamente no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech).

Normativa:

As diretrizes para o programa estão detalhadas no POP nº 09, Acesso, preenchimento e contabilização dos dados da Planilha de Registro de Atendimentos do Programa Municipal de Tratamento do Tabagismo, e POP nº 18, Condução de grupos do Programa Municipal de Tratamento do Tabagismo, disponíveis em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#).

2.2.6.2 Campanha de prevenção e diagnóstico do câncer bucal

Em conformidade com a Lei Federal nº 13.230/2015, Joinville celebra anualmente na primeira semana de novembro a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal.

- Ações na APS: durante este período, os profissionais da APS devem priorizar espaços na agenda para exames clínicos de demanda livre, focados na busca ativa de lesões suspeitas;
- Estratégia de rede: paralelamente às campanhas de conscientização na mídia municipal, a rede deve garantir a ampliação temporária das vagas na especialidade de Estomatologia (CEO), assegurando agilidade no diagnóstico definitivo e no encaminhamento para tratamento especializado de casos confirmados;
- Educação comunitária: disponibilizar materiais informativos e ações em locais de grande circulação para orientar a população sobre o autoexame e os principais fatores de risco.

2.2.6.3 Programa Saúde na Escola (PSE)

O PSE em Joinville consolidou-se como uma política intersetorial estratégica, unindo saúde e educação (Decreto nº 6.286/2007 e Portaria Interministerial nº1.055/2017). O programa visa o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem



o desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública. No âmbito municipal, as ações são desenvolvidas pelas eSBs em parceria com as escolas municipais e estaduais, em estrito cumprimento ao termo de compromisso municipal do PSE no município.

Normativa:

Para a correta contabilização dos indicadores e registro em prontuário eletrônico, os profissionais devem seguir o POP nº 46, Registro de Ações em Odontologia do Programa Saúde na Escola (PSE) no Prontuário Eletrônico do Sistema SIG-SaudeTech, disponível em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#).

2.2.6.4 Visitas e atendimentos domiciliares

Em conformidade com a PNAB, as visitas e atendimentos domiciliares são atribuições de todos os profissionais da APS, abrangendo residências particulares, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos e outras modalidades de moradia no território.

- Critérios de acesso: o deslocamento da eSB ocorre exclusivamente para usuários com restrição total de mobilidade ou condições clínicas que impossibilitem o transporte até a unidade de saúde, mediante planejamento e priorização da equipe;
- Escopo de atuação: no ambiente domiciliar, a equipe deve realizar ações de educação em saúde, orientações de higiene bucal e procedimentos preventivos (como ATF). Procedimentos de baixa complexidade, como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), podem ser realizados desde que o ambiente apresente condições mínimas de biossegurança e iluminação;
- Complexidade: caso a necessidade clínica extrapole a capacidade do atendimento domiciliar ou exija infraestrutura hospitalar, a eSB deve realizar o encaminhamento para a especialidade de Pacientes com Necessidades Especiais (PNE).

2.2.7 Grupos de atenção à saúde bucal

A organização da atenção à saúde bucal na atenção básica, conforme preconiza o Caderno de Atenção Básica nº 17 (Saúde Bucal), adota o ciclo de vida como um eixo estruturante para o cuidado. Essa abordagem reconhece que as necessidades e os riscos em saúde bucal variam significativamente ao longo das diferentes fases da vida, desde a gestação e primeira infância, passando pela infância, adolescência, idade adulta e chegando à pessoa idosa.



2.2.8 Atendimento às urgências odontológicas na APS

O acolhimento às urgências na atenção primária é um direito do usuário, amparado pela PNSB e pelo Código de Ética Odontológica. Conforme o Art. 11, inciso VII do referido código, constitui infração ética "deixar de atender usuário que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro CD em condições de fazê-lo".

2.2.8.1 Fluxo e organização da agenda para urgências na APS

Para garantir a prontidão do serviço, a organização da agenda deve seguir os seguintes critérios:

- Reserva de vagas: cada profissional deve reservar, ao menos uma (01) vaga por turno de trabalho para o atendimento de urgências;
- Flexibilidade: a oferta de vagas pode ser ampliada/adequada conforme a demanda espontânea da unidade e a disponibilidade da eSB;
- Escuta qualificada: cabe à equipe realizar a escuta qualificada dos usuários que buscam atendimento imediato para a identificação de suas necessidades em saúde bucal, fundamentando-se nas diretrizes do CFO (2021).

2.2.8.2 Natureza das urgências

Sob a perspectiva clínica, a maioria das situações de dor ou sofrimento agudo não implica risco imediato à vida. Contudo, a eSB deve estar apta a identificar condições críticas que exigem intervenção imediata ou encaminhamento hospitalar, tais como:

- Infecções orofaciais disseminadas: que podem evoluir para obstrução de vias aéreas ou septicemia;
- Hemorragias bucais: espontâneas, traumáticas ou pós-operatórias;
- Traumatismos alvéolo-dentários graves.

Independentemente da complexidade, toda urgência demanda condutas prioritárias para alívio dos sintomas dolorosos e restabelecimento da função. As abordagens técnicas e os fluxos de atendimento à demanda espontânea seguem as orientações do Caderno de Atenção Básica nº 17 (Saúde Bucal) e diretrizes complementares do Ministério da Saúde.

É fundamental a compreensão do fluxo assistencial e da vocação de cada ponto da rede de atenção à saúde. As UBSF realizam o acolhimento e a resolução das urgências odontológicas que as procuram, integrando esses atendimentos à sua rotina de ações



programáticas, preventivas e coletivas. No entanto, deve-se observar que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) constituem os pontos de atenção de vocação plena e exclusiva para o suporte às urgências e emergências. Assim, enquanto a UBSF concilia a demanda espontânea com o acompanhamento longitudinal das famílias, a UPA funciona como o suporte estratégico da rede para absorver intercorrências de forma prioritária durante todo o seu período de funcionamento, garantindo que a densidade tecnológica e a agilidade necessárias às situações de dor e trauma sejam prontamente atendidas, independentemente da complexidade do caso.

2.2.9 Continuidade do cuidado: encaminhamentos e referência

A continuidade do cuidado no município é garantida através de um sistema de referência e contrarreferência estruturado. O encaminhamento para o atendimento odontológico especializado é prerrogativa do CD da APS, realizado obrigatoriamente via sistemas de gestão adotados pela Secretaria Municipal de Saúde (atualmente SIG-SaudeTech) ou Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

Para a efetividade da regulação, o encaminhamento deve conter a descrição clínica detalhada, a justificativa da necessidade da especialidade e o registro de exames complementares realizados (radiografias, exames laboratoriais, etc.). A distribuição das especialidades no município segue a organização descrita no Quadro 07.

Quadro 07. Pontos da RASB e especialidades odontológicas

PONTOS DE ATENÇÃO	ESPECIALIDADES
Centros de Especialidades Odontológicas	Periodontia, Cirurgia Oral Menor, Endodontia, Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), Prótese Total, Disfunção Temporomandibular (DTM), Estomatologia (diagnóstico bucal) e Odontopediatria.
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria	Cirurgia e trauma bucomaxilofacial infantil, Pessoas com Deficiência (infantil), Fissuras Labiopalatinas (infantil) e Odontopediatria.
Hospital São José	Cirurgia e trauma buco maxilo facial adulto.
Hospital Bethesda	Pessoas com Deficiência (adultos).
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt	Cirurgia Bucomaxilofacial de Fissuras Labiopalatinas (adultos).

Elaborado: Unidade Técnica de Odontologia, 2026.



2.2.9.1 Controle de contra referências e continuidade do cuidado

A contrarreferência é o dispositivo que formaliza o retorno do usuário da atenção especializada para a APS, sendo indispensável para a integralidade da RASB. Ela garante que a eSB da UBSF tome ciência do tratamento realizado pelo especialista e assuma a manutenção da saúde bucal do paciente.

- Fluxo operacional: o acompanhamento e a baixa das contra referências são obrigatórios e devem ser realizados via sistema SIG-SaudeTech.
- Procedimento no sistema: o profissional deve acessar o caminho: Agenda local > Gerenciamento de contra referências, registrando as informações pertinentes sobre o desfecho do tratamento especializado e as orientações para o acompanhamento longitudinal.
- Objetivo: este controle fortalece a comunicação entre os níveis de atenção, evita a fragmentação do cuidado e otimiza a gestão das filas de espera no município.

2.2.10 Atenção por ciclo de vida

Ao organizar a atenção por meio do ciclo de vida, a eSB é orientada a planejar e executar ações específicas e direcionadas para cada etapa.

Quadro 08. Matriz de cuidados odontológicos por ciclo de vida

CICLO DE VIDA	FOCO CLÍNICO E PREVENTIVO PRINCIPAL	DIRETRIZ/META ASSISTENCIAL
Bebês (0-2 anos)	Aleitamento materno, higiene incipiente e prevenção da cárie precoce.	1ª Consulta até os 12 meses.
Crianças (2-12 anos)	Selantes, fluoroterapia, monitoramento da oclusão e controle de cárie/gengivite.	Mínimo 01 atendimento anual (Individual ou Grupo).
Adolescentes (12-18 anos)	Traumatismos, doenças periodontais e riscos dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), como Vapes/Cigarros Eletrônicos.	Mínimo 01 atendimento anual.
Adultos	Doenças periodontais, lesões não cariosas (desgaste/erosão) e impactos do tabagismo.	Conforme necessidade individual e fatores de risco.
Gestantes	Pré-natal odontológico: controle periodontal, controle de quadros inflamatórios e infecciosos e orientações para o recém-nascido.	Prioridade total: Acesso a Primeira Consulta por "Porta Aberta" e vínculo imediato.



Idosos	Xerostomia, periodontia e rastreamento preventivo do Câncer Bucal.	Mínimo 01 atendimento anual (Individual ou Grupo).
--------	--	--

Elaborado: NGQ, 2026.

2.2.11 Condições de saúde específicas

O atendimento a usuários com condições sistêmicas crônicas exige monitoramento rigoroso e manejo clínico diferenciado para prevenir intercorrências. O planejamento assistencial deve seguir o Quadro 09.

Quadro 09. Matriz de manejo para condições sistêmicas

CONDIÇÃO DE SAÚDE	PROTOCOLO DE SEGURANÇA E MANEJO	ATENÇÃO ESPECIAL (RISCOS)	META ASSISTENCIAL
Hipertensão Arterial (HAS)	Aferição de Pressão Arterial (PA) obrigatória em toda consulta. Controle de dor e estresse.	Adiar se PA igual ou maior que 160/100 mmHg. Cuidado com Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs) e vasoconstritores.	Mínimo 01 atendimento anual. (Individual ou Grupo)
Diabetes (DM)	Consultas matutinas, de preferência. Verificar glicemia e uso de medicação.	Adiar invasivos se glicemia > 200 mg/dL. Risco de hipoglicemia e infecções.	Mínimo 01 atendimento anual. (Individual ou Grupo)
Doença falciforme	Atendimento em períodos de estabilidade. Cuidado integrado médico/odontológico.	Profilaxia antibiótica em invasivos. Risco de crises falcêmicas e atraso na erupção.	Mínimo 01 atendimento anual. (Individual ou Grupo)
Doença renal crônica	Atendimento no dia seguinte à hemodiálise (sem heparina e com equilíbrio metabólico).	Ajuste de dose dos medicamentos pela filtração glomerular. Evitar AINEs e nefrotóxicos.	Conforme cronograma dialítico/anual.



Vírus da imunodeficiência humana (HIV)	Precauções Padrão (Biossegurança). Diagnóstico precoce de lesões oportunistas.	Sigilo ético absoluto, e, antes de procedimentos invasivos, avaliar os exames laboratoriais recentes. *Neutrófilos abaixo de 500/mm ³ podem exigir profilaxia antibiótica	Mínimo de 01 exame clínico individual anual. Incluir obrigatoriamente na busca ativa da Semana de Prevenção do Câncer Bucal devido ao risco elevado de lesões malignas e oportunistas.
Oncológicos	Adequação bucal prévia ao tratamento (eliminar focos infecciosos).	Risco de mucosite, xerostomia e osteorradionecrose (cabeça/pescoço).	Prioridade de atendimento pré-imunossupressão.
Transplantados	Fase pré-transplante: Adequação bucal prévia ao tratamento (eliminar focos infecciosos). Fase Pós-Transplante Imediato (até 6 meses): Procedimentos eletivos devem ser adiados. Fase Pós-Transplante Estável (Após 6 meses): tratamentos de rotina na APS.	Avaliar com a Equipe médica a necessidade de profilaxia antibiótica antes de procedimentos invasivos (risco de infecções oportunistas e endocardite).	Prioridade de atendimento pré-imunossupressão.

Elaborado: Unidade Técnica de Odontologia (UTO), 2026.

2.3 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E SERVIÇOS ESPECIAIS

A atenção especializada atua como um suporte de maior densidade tecnológica para a APS, dando continuidade aos planos de tratamento que exigem intervenções específicas. Este nível de atenção é composto pelos CEOs, pelo Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (NAIPE DI/TEA) e pelo Centrinho Prefeito Luiz Gomes.

O funcionamento desta rede baseia-se em três pilares fundamentais:

- Coordenação pela UBSF: a UBSF permanece como o "centro de comunicação" do usuário. Mesmo durante o tratamento especializado, a equipe de origem deve monitorar o progresso do paciente, garantindo que o vínculo assistencial não seja rompido;

- Fluxo de referência e contrarreferência: o encaminhamento (referência) deve ser qualificado e justificado. Após a conclusão da etapa especializada, o profissional de referência tem o dever ético e técnico de realizar a contrarreferência via Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech), descrevendo detalhadamente os procedimentos executados e as orientações necessárias para que a UBSF retome o acompanhamento longitudinal;
- Cuidado compartilhado e apoio matricial: a relação entre os níveis de atenção não deve ser apenas documental, mas dialógica. Incentiva-se que especialistas e equipes de saúde bucal da APS realizem encontros periódicos e atividades de educação permanente, compartilhando saberes para aumentar a resolutividade de casos complexos no território.

2.3.1 Pontos de atenção e especialidades

O município dispõe de unidades estratégicas com escopos de atuação distintos, conforme detalhado no [Quadro 10](#).

Quadro 10. Unidades de referência especializada em Joinville

UNIDADE	PERFIL DE ATENDIMENTO	ESPECIALIDADES OFERTADAS
CEO Tipo II Bucarein	Ambulatorial (Municipal)	Diagnóstico Bucal, Endodontia, Periodontia, Cirurgia Oral Menor, Prótese Total, DTM e PNE.
CEO Tipo II Univille	Ambulatorial (Consórcio CISNordeste)	Diagnóstico Bucal, Endodontia, Periodontia, Cirurgia Oral Menor e PNE, com abrangência regional.
NAIPE DI/TEA	Específico para Deficiência Intelectual e Autismo	Tratamento odontológico integral para pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista assistidas pelo NAIPE.
Centrinho Prefeito Luiz Gomes	Reabilitação de Fissuras Labiopalatinas e Deficiência Auditiva	Cirurgia BMF, Ortodontia/Ortopedia, Implantodontia, Clínica Geral, Odontopediatria e Reabilitação de fissuras lábio-palatais.

Elaborado: NGQ, 2026.

2.3.2 Fluxo assistencial e regulação

O acesso aos serviços especializados não é por demanda espontânea, mas sim

regulado para garantir a equidade:

- Ingresso: o agendamento da primeira consulta é realizado pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde, via sistema online, respeitando critérios de prioridade clínica.
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): antes de qualquer intervenção no serviço especializado, é obrigatória a assinatura do TCLE (Disponível no SIG-SaudeTech: Prescrições livres > Termo > TCLE).
- Retornos: uma vez iniciado o tratamento no especialista, os retornos são agendados diretamente na unidade especializada até a conclusão da etapa proposta.

2.3.3 A contrarreferência e a continuidade do cuidado

A alta no serviço especializado não encerra o cuidado ao usuário. O encerramento do caso deve seguir os seguintes critérios:

- Dever do especialista: emitir a contra referência detalhando o tratamento realizado e as orientações para a manutenção na APS.
- Dever da APS: monitorar o retorno do usuário pelo SIG-SaudeTech (Agenda local > Gerenciamento de contra referências) e dar continuidade ao plano de cuidado integral.
- Educação e matriciamento: os especialistas devem atuar no suporte técnico às eSBs da atenção primária, participando de ações de educação permanente e discussões de casos complexos.

2.4 TELEODONTOLOGIA (RESOLUÇÃO CFO-SEC-278/2025)

A norma atual autoriza o exercício da profissão à distância para fins de atenção, educação, gestão, prevenção e promoção de saúde, exercido exclusivamente por CD. Esta comunicação pode se dar via telefone da unidade, via sistema e/ou via *e-mail* institucional, conforme a modalidade.

Estão descritas no Quadro 11 as modalidades prioritárias em Joinville.



Quadro 11. Principais modalidades odontológicas a distância

MODALIDADE	DESCRIÇÃO E OBJETIVO	BENEFÍCIO PRINCIPAL
Telediagnóstico/ interconsulta	Suporte no diagnóstico de patologias via Sistema Integrado de Telemedicina e Telessaúde de Santa Catarina (STT/SC).	Reduz o tempo de espera por laudos e reduz encaminhamentos ao CEO.
Teleconsulta	Anamnese e acompanhamento clínico remoto.	Facilita o pré-natal odontológico e o controle de pacientes crônicos.
Teletriagem/ Telerastreio	Identificação prévia de sinais e sintomas.	Organiza a fila de espera e garante que casos urgentes sejam priorizados.
Telemonitoramento	Vigilância à distância de tratamentos e pós-operatórios.	Prevenir complicações e monitorar a recuperação sem que o paciente saia de casa.
Teleconsultoria	Apoio entre profissionais sobre fluxos e protocolos.	Padronizar o atendimento na rede e resolver dúvidas clínicas rapidamente.

Elaborado: NGQ, 2026.

Com base na Resolução CFO-278/2025, a Secretaria da Saúde de Joinville fomenta a utilização da Teleodontologia como ferramenta estratégica para ampliar o acesso e qualificar o cuidado na rede municipal. A prática deve ser pautada na ética e na segurança de dados, visando otimizar os fluxos entre a atenção primária e os serviços especializados.

Incentiva-se a teleorientação e a teleconsulta para o acompanhamento do pré-natal odontológico via telefone da unidade, focando na captação de gestantes com baixa adesão ao tratamento clínico para garantir a assistência integral neste período crítico. Além disso, o telemonitoramento pode ser utilizado para a vigilância de pós-operatórios, permitindo que o profissional acompanhe a evolução da recuperação e previna complicações de forma remota e ágil.

O telediagnóstico é uma modalidade de elevado interesse estratégico para o município, sendo incentivado como uma opção futura para qualificar a assistência, auxiliar na detecção precoce de patologias e conferir agilidade à emissão de laudos técnicos. Ressalta-se que, uma vez ofertada esta modalidade, o cirurgião-dentista deverá utilizar as ferramentas e plataformas de tecnologia disponibilizadas e autorizadas pela Secretaria de



Saúde no momento, garantindo a proteção de dados dos usuários e o cumprimento dos fluxos de trabalho homologados pela gestão municipal.

2.5 URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR

Diferente da UBSF, as unidades de pronto atendimento e hospitais focam exclusivamente no alívio imediato da dor e quadros agudos e na preservação da vida. São serviços de complexidade intermediária entre as UBSFs e os hospitais e fazem parte da gerência de urgência e emergência da Secretaria de Saúde.

2.5.1 Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA/PA)

As UPAs realizam o atendimento de casos de dor aguda, hemorragias, traumas e infecções de evoluções rápidas (abscessos).

- Fluxo: o paciente pode ter o caso resolvido na UPA ou ser referenciado para a rede (CEO, hospital ou retorno à UBSF).
- Encaminhamentos: excepcionalmente, o plantonista pode encaminhar ao CEO via SIG-SaudeTech, desde que o meio bucal esteja adequado. Caso o regulador negue, o paciente deve ser direcionado à sua UBSF de referência. O encaminhamento direto da UPA para o CEO via sistema de regulação é uma medida excepcional, que só é autorizada quando trazer benefício clínico inequívoco ao paciente.

2.6 ATENÇÃO HOSPITALAR

A Atenção hospitalar é o nível de maior densidade tecnológica da RASB, acessada quando as demandas não podem ser resolvidas na APS, nos CEOs ou nas UPAs. O acesso ocorre prioritariamente via SIG-SaudeTech, ou via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em casos de emergências com necessidade de transferência imediata.

2.6.1 Fluxo por faixa etária (Deliberação 181/CIB/2017)

O direcionamento do usuário obedece a critérios de idade e porte físico para garantir a segurança anestésica e infraestrutura adequada.



Quadro 12. Fluxo por faixa etária e critérios da unidade de referência

PÚBLICO-ALVO	CRITÉRIO DE IDADE	UNIDADE DE REFERÊNCIA
Pediátrico	< 15 anos (ou < 40 kg se entre 15-19 anos)	Hospital Infantil Jeser Amarante Faria
Adulto	≥ 15 anos	Hospital Municipal São José

Nota: Pacientes entre 15 e 19 anos com menos de 40kg podem ser acolhidos no Hospital Infantil por critério técnico de porte físico.

2.6.2 Competências da atenção hospitalar

Compete aos serviços hospitalares de Joinville:

- Atendimento odontológico sob anestesia geral;
- Cirurgia de deformidades orofaciais e traumas bucomaxilofaciais;
- Atendimento cirúrgico e suporte a usuários oncológicos;
- Manejo de emergências que exijam infraestrutura hospitalar de suporte à vida;
- Encaminhamento para prótese oclusiva via Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando necessário.

2.6.3 Perfil das unidades de referência

- Hospital Municipal São José (HMSJ): unidade de referência para adultos e habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON);
- Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF): diagnóstico e tratamento cirúrgico de traumas, cistos e deformidades em adultos;
- Oncologia: apoio à APS na investigação diagnóstica e tratamento de intercorrências. A equipe de saúde bucal realiza laserterapia para manejo de mucosites e outras lesões decorrentes do tratamento antineoplásico;
- Pacientes com necessidades especiais adulto: atendimento sob anestesia geral e suporte hospitalar para pacientes com deficiência;
- Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria: unidade de referência pediátrica (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). Atua em áreas complexas como:
 - Traumatologia facial: lacerações, fraturas mandibulares, dento-alveolares e faciais em geral;
 - Deformidades e malformações: expansão de maxila, distração osteogênica,



micrognatia e correções ortognáticas;

- Patologias e infecções: tratamento de cistos, tumores odontogênicos, abscessos graves e celulites;
- Estomatologia pediátrica: manejo de anormalidades de tecidos moles (freios, rânulas, lesões vasculares);
- ATM pediátrica: tratamento cirúrgico de anquiloses e transtornos da articulação;
- Pacientes com necessidades especiais infantil: atendimento sob anestesia geral e suporte hospitalar para pacientes com deficiência.

2.7 ACESSO A SERVIÇOS SECUNDÁRIOS, TERCIÁRIOS E AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS

O encaminhamento para as especialidades secundárias e terciárias em Joinville é realizado via SIG-SaudeTech e, em casos específicos, via SISREG. O sucesso da regulação depende da descrição detalhada do quadro clínico, histórico de tentativas na APS e a garantia da adequação do meio bucal (eliminação de focos infecciosos e cáries abertas). Salvo urgências, o usuário só deve ser encaminhado após concluir o tratamento básico na UBSF.

2.7.1 Cirurgia e trauma bucomaxilofacial

A Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é a especialidade da odontologia que se dedica ao diagnóstico e tratamento cirúrgico de doenças, traumatismos, deformidades e anomalias que afetam a região bucal, maxilar, mandibular e estruturas faciais anexas.

O atendimento de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é dividido em dois grupos: adultos (usuários com idade a partir de 15 anos) e crianças (com idade até 14 anos, 11 meses e 29 dias). Além das consultas agendadas pela regulação, conforme critérios abaixo, são atendidos casos emergenciais em regime de plantão ou sobreaviso no pronto-socorro das unidades hospitalares.

2.7.1.1 Critérios de inclusão

- Traumatismo facial: lacerações faciais, fraturas mandibulares, fraturas dento-alveolares, fraturas do complexo órbito-zigomático-maxilar, fraturas nasais, fraturas de parede anterior de seio frontal;
- Deformidades da face (cirurgias ortognáticas para usuários a partir de 15 anos);



- Cistos e tumores da região bucomaxilofacial que necessitam de tratamento em ambiente hospitalar;
- Infecções da região maxilofacial: abscessos, celulites, osteomielites;
- Anormalidades dos tecidos moles intra orais: mucocelos, rânulas, cistos de erupção, lesões vasculares e macroglossia;
- Transtornos da articulação temporomandibular com necessidade de tratamento cirúrgico: anquiloses, cistos, tumores, descolamento de disco, hiperplasia condilar;
- Usuários que necessitam da remoção de dentes inclusos em ambiente hospitalar por apresentarem uma ou mais limitações temporárias ou permanentes de ordem intelectual, física, sensorial e/ou emocional que os impeçam de serem submetidos a uma situação odontológica convencional na UBSF ou CEO, principalmente: odontomas, terceiros molares inclusos e associados a cistos e tumores, dentes ectópicos, dentes supranumerários.

Importante:

Neoplasias das glândulas salivares maiores (parótida, submandibular e sublingual) deverão ser encaminhadas para avaliação médica, conforme Resolução CFM nº 1.950, de 07 de julho de 2010.

Frenulotomia/Frenectomia em bebês e crianças são realizadas pela especialidade de Cirurgia Bucomaxilofacial Pediátrica (idade de 0 a 14 anos 11 meses e 29 dias) ou cirurgião pediátrico (acima de 7 anos de idade) somente após avaliação de fonoaudiólogo com parecer favorável para realização do procedimento. Caso não tenha sido realizada esta avaliação, encaminhar para fonoaudiólogo de referência do distrito através do SIG-SaudeTech.

2.7.1.2 Critérios de exclusão

- Usuários que necessitam de tratamento odontológico e que podem ser submetidos a uma situação odontológica convencional nos outros níveis de atenção à saúde;
- Estomatologia.

2.7.2 Estomatologia

A Estomatologia é a especialidade que tem como finalidade diagnosticar e tratar as doenças que se manifestam na cavidade bucal e no complexo maxilomandibular.

2.7.2.1 Critérios de inclusão

- Lesões estomatológicas do complexo maxilo-mandibular;
- Manifestações bucais de doenças sistêmicas;
- Repercussões bucais do tratamento antineoplásico;



- Lesões ou úlceras persistentes (evolução superior a 20 dias), após tratamento e/ou acompanhamento na UBSF.

2.7.2.2 Critérios de exclusão

- Lesões com menos de 20 dias de acompanhamento na UBSF;
- Herpes recorrente;
- Gengivostomatite herpética primária;
- Estomatite aftosa recorrente;
- Candidíase e estomatite protética sem prévia tentativa de tratamento na APS;
- Queilite angular;
- Usuários que necessitem de atendimento hospitalar por razões locais ou sistêmica, relacionadas ao procedimento, à condição de saúde ou à colaboração. Neste caso, encaminhar para a especialidade cirurgia bucomaxilofacial;
- Neoplasias das glândulas salivares maiores (parótida, submandibular e sublingual) deverão ser encaminhadas para avaliação médica, conforme Resolução CFM nº 1.950/2010.

Importante:

É imprescindível que conste no encaminhamento a descrição da lesão: localização, tempo de evolução, número, tamanho, limites, consistência, coloração, fatores de risco e hipótese diagnóstica. A especialidade dará ênfase para o diagnóstico precoce e prevenção do câncer de boca.

2.7.3 Cirurgia oral menor

A Cirurgia oral menor é a especialidade odontológica responsável pelo tratamento cirúrgico de problemas bucais que não são contemplados na APS.

2.7.3.1 Critérios de inclusão

- Exodontia de dentes inclusos;
- Exodontia de dentes parcialmente irrompidos e impactados;
- Exodontia de dentes que apresentem fatores locais que possam dificultar o procedimento: dilaceração radicular, anquilose, hipercementose, proximidade com o seio maxilar ou grande dificuldade de acesso;
- Exodontia de terceiros molares que necessitem de atendimento especializado;
- Exodontia de fragmentos radiculares (restos radiculares) intraósseos, se sintomatológico ou com patologia associada;



- Acidentes e complicações trans e pós exodontias;
- Frenectomia lingual em crianças colaboradoras para atendimento ambulatorial e em adultos com avaliação e indicação de fonoaudiólogo;
- Frenectomia do lábio superior após o desenvolvimento da pré-maxila (após a erupção dos caninos permanentes - 13 e 23);
- Exodontias múltiplas de 5 dentes ou mais, com necessidade de regularização de rebordo;
- Cirurgia pré-protética para regularização de rebordo (remoção de exostoses e tórus);
- Apicectomia de dentes tratados e retratados endodonticamente, com prognóstico favorável após procedimento.

Importante:

É pré-requisito para realização de exodontias de dentes inclusos/parcialmente irrompidos apresentar radiografia panorâmica prévia à primeira consulta com o especialista. Caso o usuário não compareça para consulta da radiologia odontológica e não tenha realizado o exame em serviço externo, será automaticamente retirado da fila para cirurgia oral menor.

Considerando que a radiografia panorâmica é pré-requisito para o atendimento especializado, o profissional de cirurgia oral menor deve realizar a avaliação integral da arcada. Caso identifique a necessidade de exodontia em outros elementos retidos, impactados ou com indicação de procedimento especializado em cirurgia oral menor não diagnosticados na atenção primária por ausência de exame por imagem, o especialista deverá proceder com a indicação e execução direta do tratamento, evitando o reencaminhamento para a mesma especialidade.

2.7.3.2 Critérios de exclusão

- Exodontias de dentes erupcionados;
- Exodontia de restos radiculares;
- Exodontia de fragmentos radiculares intraósseos (achados radiográficos), sem sintomatologia ou patologia associada. Recomendado apenas o acompanhamento;
- Usuários que não realizaram o tratamento odontológico básico;
- Usuários que necessitem de atendimento hospitalar por razões locais ou sistêmicas, relacionadas ao procedimento, à condição de saúde ou à colaboração. Neste caso, encaminhar para a especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial;
- Condições de saúde geral do usuário que impossibilitem os procedimentos cirúrgicos até que a avaliação médica e tratamento possibilitem sua inclusão e encaminhamento;



- Frenectomia do lábio superior antes da erupção caninos permanentes (13 e 23);
- Frenulotomia/Frenectomia lingual em bebês e crianças.

Dificuldade na amamentação:

Bebês que apresentam dificuldades na amamentação devem ser inicialmente avaliados e orientados pela equipe da Atenção Primária à Saúde (APS). Caso a dificuldade persista, o bebê deverá ser encaminhado com justificativa para o Banco de Leite Humano da Maternidade Darcy Vargas. O atendimento no Banco de Leite Humano funciona todos os dias das 7h às 19h e não exige agendamento prévio.

2.7.4 Endodontia

Especialidade responsável pelo tratamento de canais radiculares de dentes permanentes.

2.7.4.1 Critérios de inclusão

- Elementos dentais com margens supragengivais, acessados e medicados, indicados para endodontia (dentes permanentes, uni, bi e multirradiculares);
- Elementos permanentes indicados para retratamento endodôntico.

Importante:

Dentes sem coroa clínica que necessitem de prótese fixa poderão receber tratamento endodôntico, desde que o usuário seja devidamente orientado e manifeste interesse em realizar o tratamento protético fora do âmbito do SUS, e que o cirurgião-dentista descreva essa condição no encaminhamento. Em terceiros molares, a endodontia é indicada apenas em situações em que a exodontia não é a opção de tratamento preferencial e haja uma clara justificativa clínica para a manutenção do elemento, o tornando um elemento de importância funcional na oclusão.

2.7.4.2 Critérios de exclusão

- Usuários que não realizaram o tratamento odontológico básico;
- Dentes sem estrutura suficiente para posterior restauração na UBSF;
- Dentes com doença periodontal avançada com prognóstico duvidoso;
- Dentes sem acesso e curativo;
- Primeiro atendimento de traumatismos e infecções.

Importante:

Usuários com contraindicação de extração dentária, por exemplo, pós-radioterapia, poderão receber tratamento endodôntico de restos radiculares. O tratamento restaurador pós-endodontia na UBSF é prioritário para os usuários, com agendamento facilitado em vagas de retorno ou outras disponíveis, conforme a capacidade da Unidade.



2.7.4.3 Acompanhamento especializado após endodontia

Por tratar-se de uma especialidade que necessita de acompanhamento especializado, é necessário que o CEO assegure consulta de retorno por um período de 6 meses em caso de sintomatologia dolorosa, edema ou fístula após a conclusão da endodontia no serviço. O contato com o CEO deve ser feito entre coordenações.

2.7.5 Odontopediatria

Realiza o atendimento clínico para crianças até 12 anos, 11 meses e 29 dias, abrangendo todos os procedimentos clínicos, conforme os critérios de inclusão.

2.7.5.1 Critérios de inclusão

- Crianças com comportamento não colaborador para o tratamento odontológico na UBSF, persistindo mesmo após no mínimo duas tentativas de adaptação;
- Alterações ou lesões bucais de tecidos moles em crianças menores de 3 anos 11 meses e 29 dias.

2.7.5.2 Critérios de exclusão

- atendimentos de urgência;
- Crianças sem prévia tentativa de condicionamento e tratamento na UBSF;
- Frenectomias;
- Ortopedia ou maloclusões;
- Crianças com deficiência: neste caso, encaminhar para a especialidade de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE);
- Usuários que estão realizando tratamento odontológico pelo NAIPE, sem alta.

Observação:

Crianças que necessitam de tratamento hospitalar sob anestesia geral, são encaminhadas para odontopediatria e após avaliação, vão para especialidade de pacientes especiais para atendimento hospitalar.

2.7.6 Disfunção temporomandibular e dor orofacial

Esta especialidade realiza procedimentos para o controle da disfunção temporomandibular e dores orofaciais.



2.7.6.1 Critérios de inclusão

- Estalidos ou crepitação na articulação temporomandibular desde que acompanhados de sintomatologia dolorosa e/ou travamento ou limitação de abertura e das funções orais;
- Dores na articulação e/ou nos músculos da mastigação;
- Dificuldade ou impedimento dos movimentos excursivos da mandíbula (abertura, fechamento, lateralidade ou protrusão);
- Dores orofaciais: nociceptiva, neurogênica, psicogênica e mista;
- Travamentos mandibulares recorrentes;
- Limitação funcional mandibular importante;
- Trismo;
- Dor associada à mastigação, abertura bucal ou função mandibular;
- Deslocamentos mandibulares e suspeitas de alterações articulares funcionais;
- Cefaleias associadas à suspeita de DTM, após avaliação médica quando indicada;
- Zumbido associado à suspeita de componente somatossensorial, após avaliação otorrinolaringológica quando indicada;
- Pacientes com bruxismo associado à dor, limitação funcional, fadiga muscular ou impacto funcional significativo;
- Pacientes com suspeita de componente articular ativo, inflamatório ou degenerativo relacionado à ATM.

2.7.6.2 Critérios de exclusão

- Usuários que não realizaram o tratamento odontológico básico;
- Usuários que necessitarem de intervenções cirúrgicas;
- Usuários que sofreram macrotraumas importantes (quedas, atropelamentos e outros) deverão ser acompanhados prioritariamente por CTBMF;
- Usuários com queixa de estalidos assintomáticos e não limitantes;
Obs.: o cirurgião-dentista da UBS deverá fazer as orientações pertinentes ou em caso de dúvidas, contactar os especialistas.
- Pacientes com sinais clínicos de desgastes dentários exacerbados e grande perda de dimensão vertical de oclusão, nos quais é necessário reabilitação extensas, fora do âmbito SUS;
- Pacientes com doença odontológica ativa sem tratamento prévio adequado,



incluindo cárie extensa, abscessos, necessidade endodôntica, exodontias indicadas ou doença periodontal ativa;

- Pacientes com bruxismo assintomático, desgaste dentário isolado ou fraturas restauradoras sem dor e sem limitação funcional associada;
- Pacientes encaminhados exclusivamente para confecção de placa oclusal sem quadro funcional compatível com os critérios de inclusão da especialidade;
- Pacientes com necessidade predominantemente reabilitadora, ortodôntica ou protética;
- Pacientes com suspeita predominante de distúrbios respiratórios do sono, especialmente aqueles com obesidade importante, ronco intenso, pausas respiratórias noturnas, sonolência diurna excessiva e desgaste dentário associado ao provável bruxismo do sono secundário, sem quadro funcional típico de DTM ativa;
- Pacientes com histórico sugestivo de refluxo gastroesofágico, azia, regurgitação, sintomas digestivos compatíveis ou presença de lesões erosivas dentárias compatíveis com erosão ácida intrínseca, especialmente quando associados a desgaste dentário generalizado sem quadro funcional típico de DTM ativa.

Importante:

Não especificar o tratamento que será realizado, como a confecção de placas e dispositivos. A melhor abordagem será definida pelo especialista.

2.7.7 Periodontia

Especialidade responsável pelo diagnóstico e tratamento de condições periodontais que demandam um nível de intervenção além do que é oferecido pela APS.

2.7.7.1 Critérios de inclusão

- Tratamento das periodontites moderadas e severas por meio de raspagem e alisamento radicular subgengival, com ou sem necessidade de acesso cirúrgico;
- Cirurgias periodontais para dentística restauradora: gengivectomia, aumento de coroa clínica (o usuário deverá ter realizado radiografia interproximal);
- Tratamento de lesões de furca.

2.7.7.2 Critérios de exclusão

- Usuário sem adequação do meio bucal, sem orientações de higiene oral;



- Raspagem e alisamento coronário e radicular supragengival;
- Tratamentos de urgência: quadros agudos, ulcerativos e abscessos periodontais devem ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e/ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA/PA).

Importante:

Descrever no momento do encaminhamento halitose, grau de mobilidade, localização (generalizada ou localizada), profundidade de sondagem, perda de inserção e retrações. Os usuários que realizaram cirurgia para aumento de coroa clínica deverão receber tratamento restaurador na UBSF entre 15 a 30 dias após a cirurgia, de acordo com a disponibilidade de agenda da unidade. Os usuários que responderem adequadamente ao tratamento periodontal no CEO, após a conclusão e preservação, serão orientados a retornar à UBSF para a manutenção. A APS deverá intervir nos fatores modificadores da doença periodontal, raspagem e alisamento supragengival e subgengival de menor complexidade, remoção de outros fatores de retenção de placa, orientações de higiene bucal e demais procedimentos cirúrgicos compatíveis com a capacidade instalada. Gengivectomia e aumento de coroa clínica podem ser realizados na UBSF conforme disponibilidade técnica.

2.7.8 Prótese total

Realiza o tratamento protético por meio de próteses totais de usuários edêntulos em uma ou ambas as arcadas, no método tradicional ou por meio do fluxo digital.

2.7.8.1 Critérios de inclusão

- Usuários que necessitam de prótese total em uma ou ambas as arcadas;
- Usuários que necessitam de reembasamento da prótese total.

2.7.8.2 Critérios de exclusão

- Usuários que apresentam limitações temporárias ou permanentes de ordem intelectual, física, sensorial e/ou emocional que impeçam de ser submetidos a uma situação odontológica convencional;
- Usuários sem adequação do meio bucal, ou seja, com presença de restos radiculares, dentes com extração indicada, cárie, entre outras afecções;
- Usuários com lesões bucais deverão ser encaminhados previamente para Estomatologia.



Importante:

A especialidade poderá realizar próteses parciais removíveis, quando o usuário possui o arco antagonista totalmente edêntulo e com indicação para prótese total. Para isso solicitar a prótese parcial do antagonista associada a prótese total no encaminhamento.

2.7.9 Pacientes com Necessidades Especiais (PNE)

Especialidade que atende usuários que apresentam uma ou mais limitações temporárias ou permanentes de ordem intelectual, física, sensorial e/ou emocional que os impeçam de ser submetidos a uma situação odontológica convencional.

Os encaminhamentos a PNE deverão ser acompanhados de uma descrição do quadro de saúde do usuário, quantas tentativas de atendimento (com as datas), procedimentos realizados e demais informações que justifiquem o encaminhamento.

2.7.9.1 Critérios de inclusão

- Usuários com espasticidade (movimentos involuntários) que coloquem em risco a sua integridade física e daqueles que estiverem atendendo;
- Usuários com transtorno do espectro autista, sofrimento mental ou deficiência Intelectual que limitem o atendimento nas UBSF, após pelo menos duas tentativas;
- Usuários com histórico médico e condições complexas de saúde que necessitem de atenção especializada, por exemplo oncologia, obesidade mórbida, pré-operatório de cirurgias cardíacas e transplantes.

2.7.9.2 Critérios de exclusão

- Crianças não colaboradoras sem qualquer outra limitação - estes casos deverão ser encaminhados previamente para a especialidade de odontopediatria. Se necessário, a odontopediatra encaminhará para avaliação na especialidade;
- Pessoas com Deficiência sob a perspectiva de atendimento hospitalar;
- Usuários com doença sistêmica descompensada. Estes casos deverão passar por avaliação médica prévia e somente ser encaminhados após a regularidade do acompanhamento médico;
- Usuários aptos ao atendimento na APS: usuários com deficiência motora, visual, auditiva, de linguagem, obesidade, gestantes, cardiopatas, idosos, HIV positivos, portadores de hepatites virais, doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes, transplantados, etc.) ou autoimunes, que não apresentem limitações que impeçam



o atendimento odontológico na APS.

2.8 SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

A resolutividade clínica na RASB de Joinville fundamenta-se na integração entre o exame físico minucioso e o uso racional de tecnologias de suporte. O acesso a exames complementares e à assistência farmacêutica municipal permite que o cirurgião-dentista atue com maior precisão diagnóstica, monitore condições sistêmicas que impactam o tratamento odontológico e garanta a segurança farmacológica do usuário. Estes recursos devem ser utilizados de forma criteriosa, pautados na evidência clínica e na otimização dos fluxos regulatórios vigentes.

2.8.1 Assistência farmacêutica

Os CD de Joinville possuem autonomia plena para prescrever medicamentos essenciais ao manejo odontológico, abrangendo desde a analgesia e a antibioticoterapia até protocolos de profilaxia específicos.

- Onde retirar: farmácias e dispensários das unidades de saúde.
- Regramento: a prescrição deve seguir rigorosamente a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME).
- Consulta Técnica: a lista atualizada de fármacos e suas concentrações está disponível no Processo SEI nº 20.0.109264-9.

2.8.2 Radiologia odontológica

Os exames radiológicos são ferramentas auxiliares no diagnóstico odontológico e devem ser solicitados somente após o exame clínico completo, de forma criteriosa e com o objetivo de confirmar ou complementar o diagnóstico. Para solicitar exames radiográficos, o cirurgião-dentista deve encaminhar o usuário via Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) e preencher o Formulário BPA-I (Boletim de Produção Ambulatorial – Dados Individualizados) informando a queixa principal, a descrição do caso, justificativa para o exame e os exames solicitados. O encaminhamento contempla duas categorias de radiografias: intrabucais e extrabucais, com as seguintes indicações.

2.8.2.1 Radiografias intrabucais

Radiografias periapicais são indicadas como exame complementar para o diagnóstico de:

- Lesões cariosas;
- Periapicopatias;
- Fraturas radiculares;
- Reabsorções radiculares;
- Anomalias radiculares (tamanho, forma e número);
- Dentes inclusos;
- Relação dos dentes/raízes com estruturas adjacentes;
- Relação do germe do dente permanente com o dente decíduo;
- Cronologia de desenvolvimento/erupção;
- Reabsorções/perdas ósseas alveolares.

Radiografias interproximais são indicadas como exame complementar para o diagnóstico de:

- Pesquisa de cáries proximais, cáries oclusais e recidiva de cárie;
- Observar relação cárie/câmara pulpar;
- Calcificações na câmara pulpar;
- Relação entre dentes decíduos e dentes permanentes;
- Avaliação do espaço biológico;
- Avaliação das cristas ósseas alveolares e região de furca;
- Bolsas periodontais (profundidade e defeitos ósseos).

2.8.2.2 Radiografias extrabucais

Radiografias panorâmicas são indicadas como exame complementar para o diagnóstico de:

- Avaliação de grandes alterações patológicas;
- Avaliação de alterações patológicas com as estruturas adjacentes;
- Pesquisa e localização de dentes inclusos/impactados;
- Pesquisa e localização de dentes supranumerários inclusos;
- Pesquisa e localização de raízes, lesões residuais e corpos estranhos;
- Estudo de fraturas ósseas;
- Pré-operatório – planejamento cirúrgico;
- Pós-operatório imediato e mediato;
- Exodontias múltiplas;
- Avaliação de anomalias de desenvolvimento ósseo;



- Avaliação da cronologia de desenvolvimento e/ou erupção;
- Avaliação do posicionamento dos dentes permanentes/dentes decíduos;
- Avaliação de reabsorção/perda óssea alveolar, lesões endoperiodontais, lesões de furca e bolsa/abcesso periodontal;
- Visualização e avaliação dos côndilos mandibulares;
- Visualização dos limites dos seios maxilares;
- Usuários que sentem muito desconforto com as radiografias intrabuciais;
- Usuários debilitados, devido a maior amplitude do exame em uma só tomada;
- Usuários com trismo.

Observação:

Para avaliar processos cariosos de menor porte, relação cárie/polpa, adaptações de restaurações/próteses e lesões periapicais a imagem panorâmica é limitada – deve-se, nesses casos, encaminhar para radiografia intrabucal (radiografias periapicais e/ou interproximais).

Para localização de dentes inclusos e corpos estranhos, solicitar radiografia panorâmica e radiografias periapicais dissociadas (Métodos de Clark e Miller-Winter).

Para dente incluso/mesio-dens solicitar periapical de ântero superior (intrabucal) e panorâmica (extrabucal).

Limitações para radiografia panorâmica:

O exame panorâmico exige o posicionamento preciso no plano de Frankfurt e a imobilidade total durante a varredura. São critérios de impedimento: Pacientes com estatura inferior a 1,20 m ou cadeirantes cujas dimensões impeçam o curso do braço giratório do equipamento, e pacientes com condições neurológicas ou cognitivas que impossibilitem a manutenção da estaticidade em pé (risco de movimento). Em pacientes acamados não é possível a realização do exame panorâmico.

2.8.2.3 Demais radiografias extrabuciais

A solicitação de demais radiografias extrabuciais é condicionada a exame de prováveis fraturas ou para investigação de acometimentos maiores, estão disponíveis na rede:

- Radiografia De Articulação Temporo-Mandibular Bilateral;
- Radiografia De Cranio (Pa + Lateral + Obliqua / Bretton + Hirtz);
- Radiografia De Cranio (Pa + Lateral);
- Radiografia De Maxilar (Pa + Obliqua);
- Radiografia De Ossos Da Face (Mn + Lateral + Hirtz);
- Radiografia De Seios Da Face (Fn + Mn + Lateral + Hirtz).



Quadro 13. Matriz de indicações radiográficas

CATEGORIA	TIPO DE EXAME	PRINCIPAIS INDICAÇÕES CLÍNICAS
Intrabucal	Periapical	Lesões cariosas profundas, periapicopatias, fraturas radiculares e avaliação de germes permanentes.
Intrabucal	Interproximal	Padrão-ouro para cáries interproximais, avaliação de cristas ósseas e adaptação de restaurações.
Extrabucal	Panorâmica	Planejamento de cirurgias de inclusos, traumas ósseos, cistos, tumores e avaliação global da cronologia eruptiva.
Extrabucal	ATM Bilateral	Investigação de distúrbios funcionais, anquiloses ou patologias da articulação temporomandibular.
Extrabucal	Crânio/Face	Casos complexos de fraturas maxilofaciais ou investigação de seios da face (Incidências Waters, Hirtz, Caldwell).

Elaborado: NGQ, 2025.

2.8.3 Exames laboratoriais (Análises clínicas)

A solicitação de exames laboratoriais pelo CD é uma prerrogativa que visa a segurança perioperatória e o monitoramento de intercorrências sistêmicas com manifestação bucal.

Quadro 14. Matriz de exames laboratoriais na odontologia

EXAME	FINALIDADE
Glicose (Sangue)	Avaliação do controle glicêmico para procedimentos invasivos e diagnóstico de manifestações orais da DM.
Hemograma completo	Análise de séries branca (infecções/imunidade) e vermelha (anemias), além de contagem plaquetária.
Coagulograma Tempo de Atividade da Protrombina/Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TAP/TTPA)	Avaliação da cascata de coagulação em pacientes anticoagulados ou com histórico de discrasias sanguíneas.



Velocidade de Hemossedimentação (VHS)	Indicador inespecífico de atividade inflamatória ou infecciosa sistêmica.
---------------------------------------	---

Elaborado: NGQ, 2026.

É fundamental que o profissional registre no prontuário eletrônico a conduta adotada a partir do diagnóstico laboratorial ou radiográfico. Em casos onde os exames indiquem alterações sistêmicas severas que contraindicam o procedimento odontológico imediato, o usuário deve ser referenciado à clínica médica da UBSF para estabilização, garantindo assim o preceito da na RAS.

2.9 SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS OU LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

O Serviço de Suporte de Próteses Dentárias do município é a unidade de referência para a reabilitação oral de usuários desdentados totais, visando restabelecer as funções mastigatórias, fonéticas e a autoestima dos cidadãos.

- Fluxo de acesso: o ingresso neste serviço ocorre exclusivamente por meio de encaminhamento realizado pelo Cirurgião-Dentista da Atenção Primária à Saúde (APS), via sistema de regulação municipal (SIG-SaudeTech).
- Condição clínica obrigatória: para que o encaminhamento seja efetuado e autorizado, o usuário deve possuir no mínimo 1 arcada edêntula, sem reabilitação protética e alta odontológica recente na UBSF de referência. Isso assegura que o meio bucal esteja devidamente adequado, com a conclusão de todos os tratamentos periodontais, cirúrgicos e restauradores necessários, garantindo uma base saudável para a instalação das próteses.

Cabe à equipe de saúde bucal do território realizar a triagem inicial e as orientações sobre a importância da reabilitação, além de realizar o acompanhamento após a entrega das peças.

3. INDICADORES, MONITORAMENTO E CONTROLE

Os indicadores de saúde são ferramentas fundamentais que traduzem a realidade clínica e a oferta de serviços em dados mensuráveis. Eles permitem avaliar o impacto das ações de saúde bucal na população de Joinville e orientam a tomada de decisões estratégicas para a alocação de recursos e expansão da rede.

A fidedignidade dos indicadores depende diretamente da precisão e do

detalhamento dos registros realizados no SIG-SaudeTech. O compromisso com o registro correto é a base para a formulação de políticas públicas eficazes e para a sustentabilidade financeira do serviço.

3.1 NÍVEIS DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO

A gestão da saúde bucal em Joinville observa três instâncias principais de metas e avaliação, detalhadas no [Quadro 15](#).

Quadro 15. Matriz de indicadores e instrumentos de gestão

INSTÂNCIA DE GESTÃO	FOCO DO MONITORAMENTO	IMPACTO PARA A eSB
Indicadores do Ministério da Saúde	Desempenho em acesso, produção e ações preventivas (ex: Saúde na Escola).	Sustentabilidade da rede: o alcance das metas garante o repasse de recursos federais para o município.
Plano Municipal de Saúde	Metas específicas para Joinville, revisadas a cada 4 anos.	Gestão Local: orienta as prioridades assistenciais do território.
SB Brasil (Pesquisa Nacional)	Levantamento epidemiológico de larga escala (Cárie, Periodontia, etc.).	Estratégia: define o panorama epidemiológico para planejamento a longo prazo.

Elaborado: Unidade Técnica de Odontologia, 2026.

3.2 O PAPEL DO REGISTRO

Para que os indicadores reflitam a real produtividade e necessidade da população, o cirurgião-dentista e sua equipe devem assegurar que:

- Identificação nominal: todo atendimento seja vinculado ao Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do usuário.
- Codificação correta: uso rigoroso dos códigos de procedimentos, Classificação Internacional de Doenças (CID) e Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) correspondentes à queixa e ao tratamento realizado.
- Sincronização de dados: garantia de que as informações inseridas no prontuário eletrônico local sejam processadas sem erros para o sistema nacional e-SUS.

Em última análise, a gestão por indicadores transforma o atendimento clínico

individual em um compromisso coletivo com a saúde pública. Ao assegurar registros fidedignos e acompanhar o alcance das metas estabelecidas, o cirurgião-dentista e sua equipe não apenas garantem a sustentabilidade financeira da saúde bucal no município, mas também validam a eficácia de suas intervenções. O monitoramento contínuo permite que a rede de Joinville identifique precocemente vazios assistenciais e áreas de maior risco epidemiológico, assegurando que o planejamento das ações seja dinâmico, transparente e, acima de tudo, pautado nas reais necessidades de cada território.

4. INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO (PARCERIAS)

A qualificação da rede de Saúde Bucal de Joinville está diretamente ligada à sua capacidade de ser um cenário de aprendizado. A integração entre as instituições de ensino e o serviço fortalece a assistência e promove a inovação no SUS.

4.1 O CONTRATO ORGANIZATIVO (COAPES)

A inserção de estudantes de graduação e pós-graduação nas unidades de saúde é regida pelos Contratos Organizativos de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES), conforme Portaria Interministerial nº 1.127/2015.

- Objetivo: alinhar a formação acadêmica às necessidades reais da população atendida pelo SUS.
- Cenários de prática: abrange desde a atenção primária até os serviços especializados e hospitalares.

4.2 FLUXO DE ESTÁGIOS EM JOINVILLE

A organização dos campos de prática em odontologia no município é organizada pelo Centro de Educação e Inovação em Saúde (CEIS).

- Recrutamento de unidades: o CEIS identifica as unidades com perfil e interesse em atuar como campo de estágio.
- Papel da eSB: as equipes que recebem estudantes devem atuar em sintonia com o professor preceptor da instituição de ensino.
- Dinâmica assistencial: o aluno deve ser integrado às rotinas da unidade sob supervisão, participando não apenas do atendimento clínico, mas também das ações territoriais, reuniões de equipe e atividades do PSE.



4.3 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE RECEPTORA

Para que a parceria ensino-serviço seja efetiva, a eSB deve observar as diretrizes apresentadas no Quadro 16.

Quadro 16. Responsabilidades na integração ensino-serviço

ATOR	RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
CEIS	Fomentar parcerias e organizar a distribuição dos alunos na rede.
Instituição de Ensino	Garantir o preceptor e o seguro dos alunos, alinhar o plano de ensino à rotina da UBSF.
Equipe de Saúde Bucal	Acolher o estudante, compartilhar saberes práticos e facilitar a imersão na rede.
Estudante	Cumprir normas éticas, biossegurança e os protocolos descritos neste manual.

Elaborado: NGQ, 2026.

A integração ensino-serviço, materializada pelos contratos de COAPES e pela gestão do CEIS, consolida Joinville como um polo de excelência na formação de novos profissionais de saúde. Ao acolher estudantes, as equipes de saúde bucal não apenas qualificam a assistência imediata, mas investem no futuro do SUS. Esta troca mútua entre o saber acadêmico e a prática cotidiana oxigena o serviço, incentiva a educação permanente e garante que a rede municipal permaneça atualizada e alinhada às melhores evidências científicas e humanísticas da odontologia contemporânea.

5. PROPÓSITO E DIRETRIZES DA REDE DE CUIDADO

Este guia de linha de cuidado da saúde bucal de Joinville representa o compromisso do município com uma assistência odontológica integrada, resolutiva e centrada no cidadão. Ao percorrer desde o acolhimento na atenção primária até a densidade tecnológica da atenção especializada e hospitalar, estabelecemos um fluxo claro que prioriza a segurança do paciente e a equidade no acesso. Espera-se que este manual sirva como ferramenta viva de consulta e padronização para todas as equipes, fortalecendo a identidade da nossa rede e assegurando que cada sorriso cuidado pelo SUS em Joinville receba o melhor que a gestão pública e a prática clínica podem oferecer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. [Presidência da República]. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.

BRASIL. [Presidência da República]. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 16 jul. 1990.

BRASIL. [Presidência da República]. **Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000**. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. Brasília, DF: Casa Civil, 2000.

BRASIL. [Presidência da República]. **Decreto nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Casa Civil, 2007.

BRASIL. [Presidência da República]. **Lei nº 13.230, de 28 de dezembro de 2015**. Institui a semana nacional de prevenção do câncer bucal. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 29 dez. 2015.

BRASIL. Ministério da Educação; Ministério da Saúde. **Portaria Interministerial nº 1.127, de 04 de agosto de 2015**. Institui as diretrizes para a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES). Brasília, DF: MS, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde Bucal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 17).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica**. 1. ed., 1. reimpr. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 28, Volume II).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014**. Institui normas para a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Brasília, DF: MS, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, DF: MS, 2017.



BRASIL. Ministério da Saúde. **A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde** [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 23/2020-DESF/SAPS/MS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 34/2026-CGSB/SAPS/MS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual das doenças não cariosas e da síndrome do envelhecimento precoce bucal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Passo a Passo das Ações da Política Nacional de Saúde Bucal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2023**: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: relatório final [recurso eletrônico]. 1. ed. rev. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sb_brasil_2023_relatorio_final_1edrev.pdf. Acesso em: 24 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução CFM nº 1.950, de 07 de julho de 2010**. Estabelece critérios para realização de cirurgias das áreas de buco-maxilo-facial e crânio-maxilo-facial. Brasília, DF: CFM, 2010.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução nº 118, de 11 de maio de 2012**. Código de Ética Odontológica. Rio de Janeiro: CFO, 2012.

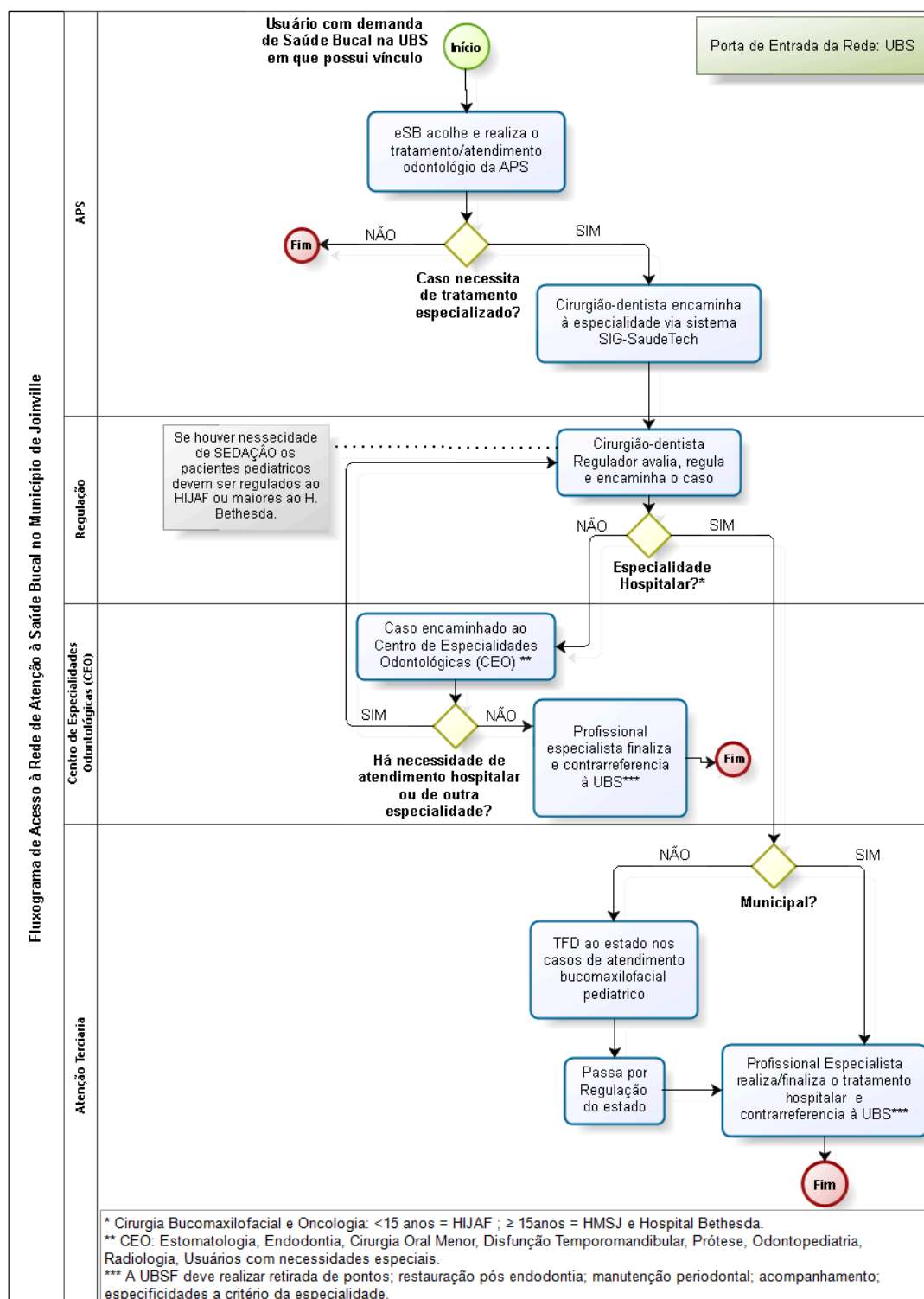
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **O que são urgências e emergências odontológicas?** [S. l.]: CFO, 2021. Disponível em:
<https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/03/CFO-URGENCIAS-E-EMERGENCIAS.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2026.

MARINHO, V. C.; WORTHINGTON, H. V.; WALSH, T.; CHONG, L. Y. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], 2015.

SANTA CATARINA (Estado). Secretaria de Estado da Saúde. **Deliberação 181/CIB/2017**. Florianópolis: SES, 2017.

ANEXOS

ANEXO A. Fluxogramas de acesso à RASB - APS



Elaborado: NGQ, 2026.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE